Ministerio de Salud
Hospital Nacional
"Hipólito Unanue"

N° 211 -2024-DG/HNHU

Resolución Directoral

Lima 12 de agosto de 2024

Visto el Expediente N° 24-034316, que contiene: el Memorando N.° 443-2024-DPTO GyO-HNHU, emitido por el Departamento de Gineco - Obstetricia, a través del cual solicitó la aprobación del proyecto de Guía Técnica: "Guía de Práctica Clínica para Diagnóstico y Tratamiento del Climaterio", y;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud disponen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo, y que la protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el artículo 37 de la precitada Ley, establece que los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional (...);

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2006-SA, se aprueba el Reglamento de Establecimiento de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, el cual tiene por objetivo establecer los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento;

Que, el segundo párrafo del artículo 5 del acotado Reglamento, establece que los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben contar en cada área, unidad o servicio, con manuales de procedimientos, guías de práctica clínica referidos a la atención de los pacientes, personal, suministros, mantenimiento, seguridad y otros que sean necesarios, según sea el caso;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 302-2015/MINSA, se aprobó la NTS N° 117-MINSA/DGSP-V.01- "Norma Técnica de Salud para la Elaboración y Uso de Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud", con la finalidad de contribuir a la calidad y seguridad de las atenciones de salud, respaldadas por Guías de Práctica Clínica, basadas en evidencias científicas, ofreciendo el máximo beneficio y el mínimo riesgo para los usuarios de las prestaciones en salud, así como la optimización y racionalización del uso de los recursos;

Que, asimismo, con Resolución Ministerial N° 414-2015/MINSA, se aprobó el Documento Técnico: "Metodología para la Elaboración de Guías de Práctica Clínica", con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de la atención en salud, con énfasis en la eficiencia, efectividad y seguridad; a través, de la formulación de Guías de Práctica Clínica que respondan a las prioridades nacionales, regionales y/o locales;

BOG. Braulio Raúl Raez V.
FEDATARIO
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
19 AGO. 2024
El presente documento es
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
que he tenido a la vista

Que, de la misma manera, mediante Resolución Ministerial Nº 826-2021/MINSA, se aprobó el Documento denominado "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud", cuyo objetivo general es establecer las disposiciones relacionadas con los procesos de formulación, aprobación, modificación y difusión de los documentos normativos que expide el Ministerio de Salud, siendo de observancia obligatoria por los órganos, unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Ministerio de Salud;

Que, con Resolución Directoral N° 075-2022-HNHU-DG, se aprobó la Directiva Administrativa N° 045-HNHU/OPE-2022 "Directiva Administrativa para la elaboración de documentos normativos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue", el cual tiene por finalidad facilitar criterios únicos para la presentación y aprobación de documentos normativos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue;

Que, el punto 6.1.3. del citado documento normativo, describe a la Guía Técnica como el documento normativo con el que se define por escrito y de manera detallada el desarrollo de determinados procesos, procedimientos y actividades administrativas, asistenciales o sanitarias. En ella se establecen metodologías, instrucciones o indicaciones que permite al operador seguir un determinado recorrido, orientándolo al cumplimiento del objetivo de un proceso, procedimientos o actividades, y al desarrollo de una buena práctica;

Que, el artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue, aprobado con Resolución Ministerial Nº 099-2012/MINSA, en adelante ROF-HNHU, señala entre otros, que son funciones generales del Hospital administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes; así como mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención de la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno familiar;

Que, el literal f) del artículo 56 del ROF-HNHU, señala como una de las funciones del Departamento de Gineco-Obstetricia: Actualizar, difundir, monitorizar y ejecutar las guías de práctica clínica y procedimientos de atención orientado a brindar un servicio eficiente y eficaz de acuerdo a la categoría e indicadores FONE del hospital, orientados a proporcionar un servicio eficiente y eficaz;

Que, asimismo, el artículo 11° del ROF-HNHU, señala que La Oficina de Gestión de la Calidad es la unidad orgánica que se encarga de implementar el Sistema de Gestión de la Calidad en el Hospital para promover la mejora continua de la atención asistencial y administrativa al paciente con la participación activa del personal; y, en el literal f) del mencionado artículo señala que dentro de sus funciones generales se encuentra: Asesorar en la formulación de normas, guías de atención y procedimientos de atención al paciente;

Que, en este contexto, mediante Memorando N° 443-2024-DPTO GyO-HNHU de fecha 26 de julio de 2024, el Departamento de Gineco-Obstetricia, presentó a la Oficina de Gestión de la Calidad, el proyecto de Guía Técnica: "Guía de Práctica Clínica para Diagnóstico y Tratamiento del Climaterio" el cual tiene como objetivo: Promover el cuidado integral de la mujer en edad de climaterio, otorgando herramientas sencillas basadas en la mejor evidencia disponible, de modo de facilitar la práctica del profesional y la toma de decisiones;

Que, de acuerdo a la Nota Informativa N.° 317-2024-OGC/HNHU de fecha 01 de agosto de 2024, la Oficina de Gestión de la Calidad, trasladó el Informe Nº 188-2024-

Ministerio de Salud
Hospital Nacional
"Hipólito Unanue"

Nº 211 -2024-DG/HNHU

DOG Braulio Raúl Raez Vargas
FEDATARIO
Hospital Nacional Hipólito Unánue

19 AGO. 2024

El presente documento es
COPIA FIEL DEL ORIGINAL
que he tenido a la vista

Resolución Directoral

Lima 12 de agosto de 2024

KMGM/HNHU, elaborado por la M.C. Katterin Guzmán Mancilla, a través del cual se informó a la Dirección General que el referido proyecto de Guía Técnica: "Guía de Práctica Clínica para Diagnóstico y Tratamiento del Climaterio", se encuentra dentro de los lineamientos según normativa vigente, razón por la cual es derivada a este despacho, mediante Hoja de Envío de Trámite Documentario;

Que, teniendo en cuenta la normatividad descrita e Informe del área de asesoramiento Técnico-Sanitario; y, con el propósito de continuar con el desarrollo de las actividades y procesos técnicos administrativos a nivel institucional, así como alcanzar los objetivos y metas del Hospital Nacional Hipólito Unanue, resulta pertinente aprobar la Guía Técnica: "Guía de Práctica Clínica para Diagnóstico y Tratamiento del Climaterio", propuesto por el Departamento de Gineco - Obstetricia;

Estando a lo informado por la Oficina de Asesoría Jurídica en su Informe Nº 385-2024-OAJ/HNHU;

Con el visto bueno del Departamento de Gineco - Obstetricia, la Oficina de Gestión de la Calidad y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Documento Técnico: "Metodología para la Elaboración de Guías de Práctica Clínica", aprobado con Resolución Ministerial N° 414-2015/MINSA, el Documento denominado "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud", aprobado con Resolución Ministerial Nº 826-2021/MINSA, la Directiva Administrativa N° 045-HNHU/OPE-2022 "Directiva Administrativa para la elaboración de documentos normativos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue", aprobado con Resolución Directoral N° 075-2022-HNHU-DG; y, de acuerdo a las facultades establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Nacional Hipólito Unanue, aprobado por Resolución Ministerial Nº 099-2012/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la Guía Técnica: "Guía de Práctica Clínica para Diagnóstico y Tratamiento del Climaterio" la misma que forma parte de la presente Resolución y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

Artículo 2.- ENCARGAR al Departamento de Departamento de Gineco - Obstetricia, la ejecución y seguimiento de la Guía Técnica aprobada en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 3.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones proceda a la publicación de la presente Resolución en la Página Web del Hospital https://www.gob.pe/hnhu.

Regístrese y comuníquese.

MINISTERIO DE SALUD
Hospital Nacional "Hipólito Unanue"
DR. MOISES ENRIQUE TAMBINI ACOSTA
Director General (e)
CMP: 16412

JEFATURA

META/VMIF/jlcr
DISTRIBUCIÓN.
( ) D. Adjunta
( ) Dpto. de Gineco-Obstetricia
( ) OAJ
( ) Of. Gestión de la Calidad
( ) OCI
( ) Comunicaciones
( ) Archivo

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE



GUIA TÉCNICA: GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO

2024

EQUIPO DE GESTIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNÁNUE

M.C Moisés Enrique Tambini Acosta

Director General

M.C Moisés Enrique Tambini Acosta

Director Adjunto

CPC. Arnaldo Rojas Altamirano

Director Administrativo

CPC. Juan José Castillo Serna

Director Ejecutivo de la Oficina de Planeamiento Estratégico

M.C. Víctor Raúl Arámbulo Ostos

Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad

Grupo Elaborador de la GUIA TÉCNICA: GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO

Junio 2024

M.C. DANTE MENDOZA BAEZ
Jefe del Departamento de Gineco Obstetricia

BERTHA ELIZABETH ARROYO MONTES M.C.
Jefa del Servicio de Ginecología

M.C. JUAN ADRIAN ROMERO QUISPE
Jefe del Servicio de Obstetricia Médico Quirúrgica

M.C. JUAN CARLOS AUQUI GUERRERO
Jefe de Servicio de Reproducción Humana

M.C. VERONICA LIVIAC ANICAMA
Jefa de la Unidad de Menopausia

M.C. MARIA MARTINEZ ALTAMIRANO
Médico Ginecóloga Obstetra

M.C. JESUS BONILLA YARANGA
Médico Ginecólogo Obstetra

M.C. EMALY MAURICIO ORCON
Médico Ginecóloga Obstetra

M.C. JOHAN ZAPATA MORENO
Médico Ginecólogo Obstetra

M.C. KATTERIN MERY GUZMAN MANCILLA
Médico Revisor de la Oficina de la Calidad

PROFESIONALES ELABORADORES DE LA PRESENTE GUÍA	Médicos del Servicio de Reproducción Humana del Departamento de Ginecología y Obstetricia.
CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD	Climaterio
CATEGORÍA DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA	Tercer nivel de atención
USUARIOS POTENCIALES	Médico Asistentes del Departamento de Ginecología y Obstetricia, Residentes de los 3 años de la especialidad.
POBLACIÓN BLANCO	Pacientes con Diagnóstico de Climaterio.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	La elaboración de la presente Guía de Práctica Clínica no ha recibido financiación alguna.
IMPACTO ESPERADO EN SALUD	Promover el cuidado integral de la mujer en edad de climaterio.
METODOLOGÍA	El proceso de adaptación utilizado en este documento se basó en la metodología ADAPTE sugerido por el MINSA (NT 414_2015) incluyendo la definición del enfoque de la GPC, elaboración de preguntas clínicas PICO, métodos empleados para recolectar y seleccionar evidencia, protocolo sistematizado de búsqueda (Revisión sistemática de la literatura,Búsquedas de bases de datos electrónicos y Búsqueda manual de la literatura).Ello fue seguido de la adopción de Guías de Práctica Clínica Internacionales. El proceso incluyó: selección de las guías que responden a las preguntas clínicas formuladas con información sustentada en evidencia; construcción de la guía para su validación; respuesta a preguntas clínicas por adopción de guías; análisis de evidencias y recomendaciones de las guías adoptadas en el contexto nacional y emisión de evidencias y recomendaciones.
CONFLICTO DE INTERESES:	Los autores realizaron un esfuerzo por asegurarse que la información contenida sea completa y actual; por lo que asumen la responsabilidad por el contenido de esta guía, que incluye evidencias y recomendaciones y declaran que no tienen conflictos de intereses.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Los siguientes profesionales firmantes, declaramos no tener conflicto de interés con respecto a las recomendaciones de la Guía de Procedimiento Asistencial, no tener ningún tipo de relación financiera o haber recibido financiación alguna por cualquier actividad en el ámbito profesional académico o científico.

GRUPO ELABORADOR DE LA GUIA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL	DEPARTAMENTO/ SERVICIO	FIRMA Y SELLO
M.C. Dante Mendoza Baez	Jefe del Departamento de Gineco Obstetricia	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE M.C. DANTE MENDOZA BAEZ C.M.P. Nº 32554 R.N.E. Nº 17935 Médico Jefe del Departamento de Gineco - Obstetricia
M.C Bertha Elizabeth Arroyo Montes	Jefa del Servicio de Ginecología	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "HIPOLITO UNANUE" M.C. ARROYO MONTES BERTHA ELIZABETH C.M.P Nº 31194 R.N.E. 16513 MÉDICO JEFE DE SERVICIO DE GINECOLOGÍA
M.C. Juan Vidal Romero Quispe	Jefe del Servicio de Obstetricia Médico Quirúrgica	MINISTERIO DE SALUD Hospital Nacional "Hipólito Unanue" M.C. JUAN VIDAL ROMERO QUISPE CMP. 32870 RNE. 17808 Médico Jefe de Servicio de Obstetricia Médico Quirúrgico
M.C. Juan Carlos Auqui Guerrero	Jefe del Servicio de Reproducción Humana	MINISTERIO DE SALUD Hospital Nacional "Hipólito Unanue" M.C. JUAN CARLOS AUQUI GUERRERO CMP. 64656 RNE. 33878 Médico Jefe de Servicio de Reproducción Humana
M.C. Lourdes Veronika Liviac Anicama	Jefa de la Unidad de Menopausia	L. Veronika Liviac Anicama MEDICO GINECO OBSTETRA CMP. 46885 R.N.E. 21798
M.C. Maria Olinda Martinez Altamirano	Médico Ginecóloga Obstetra	Dra. Maria Martinez Altamirano GINECOLOGA - OBSTETRICIA CMP: 46865 RNE: 23886 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
M.C. Jesús Percy Bonilla Yaranga	Médico Ginecólogo Obstetra	MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL "HIPÓLITO UNANUE" JESÚS BONILLA YARANGA GINECÓLOGO OBSTETRA CMP. 26615 RNE. 14100
M.C. Emaly Mauricio Orcon	Médico Ginecóloga Obstetra	Dra. Emaly Mauricio Orcón MÉDICO CIRUJANO GINECOLOGO - OBSTETRA CMP: 067048 / RNE: 038855

V°B° M.C. MOISES ENRIQUE TAMAYO ACOSTA JEFATURA DEPTO. GINECO-OBSTETRICIA

M.C. Johan Emerson Zapata Moreno	Médico Ginecólogo Obstetra	Johan Zapata Moreno GINECO OBSTETRA
M.C. Jhelitza Milagros Huamán Huamán	Médico Ginecólogo Obstetra	Dra. Jhelitza Huamán H. GINECOLOGÍA - OBSTETRICIA FERTILIDAD MEDICINA FETAL CMP 65265 RNE 36474

Lima, 26 de Junio del 2024

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE V°B° M.C. MOISES ENRIQUE TAMASHIRO ACOSTA DIRECCIÓN GENERAL

PREGUNTAS A RESPONDER CON LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO.

- ¿Cómo se define el climaterio?

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE JEFATURA GINECO OBSTETRICIA

- ¿Cuál es el impacto del climaterio en mujeres de 45 a 60 años?
- ¿Cuál es la precisión diagnóstica de las pruebas de laboratorio para evaluar los niveles hormonales durante el climaterio en mujeres sintomáticas?
- ¿Cuál es la eficacia de la terapia de reemplazo hormonal en el manejo de los síntomas del climaterio en mujeres postmenopáusicas?
- ¿Cuál es la diferencia en la incidencia de complicaciones entre mujeres que reciben terapia de reemplazo hormonal y aquellas que no la reciben durante el climaterio?
- ¿Cuál es la calidad de vida percibida por mujeres que reciben diferentes modalidades de tratamiento para el climaterio?
- ¿Cuál es la utilidad de los cuestionarios estandarizados para el diagnóstico temprano de síntomas del climaterio como los sofocos y la sequedad vaginal?
- ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad de las escalas de evaluación de síntomas del climaterio en comparación con el diagnóstico clínico por especialistas?
- ¿Cuál es el impacto de un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado del climaterio en la calidad de vida de las mujeres?
- ¿Cuál es la eficacia relativa de diferentes tipos de terapia de reemplazo hormonal (estrógeno solo vs. combinación de estrógeno y progestágeno) en el manejo de los síntomas del climaterio?
- ¿Cuál es la efectividad de las intervenciones no hormonales, como la fitoterapia o cambios en el estilo de vida, en la mejora de la calidad de vida durante el climaterio en mujeres con contraindicaciones para la terapia de reemplazo hormonal?
- ¿Cuál es el efecto de los suplementos de calcio y vitamina D en la prevención de la pérdida ósea durante el climaterio en mujeres postmenopáusicas?
- ¿Cuál es la satisfacción del paciente y la adherencia al tratamiento a largo plazo entre diferentes modalidades terapéuticas para el climaterio?

I. FINALIDAD

Mejorar la atención de las pacientes que acuden al Hospital Nacional Hipólito Unanue en la etapa de climaterio.

II. OBJETIVO

Promover el cuidado integral de la mujer en edad de climaterio, otorgando herramientas sencillas basadas en la mejor evidencia disponible, de modo de facilitar la práctica del profesional y la toma de decisiones.

III. AMBITO DE APLICACIÓN

Unidad de Menopausia - Servicio de Reproducción Humana, Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Criterios de inclusión:

- Todas las mujeres entre los 35 y 65 años
- mujer <35 años con falla ovárica Prematura

IV. PROCESO O PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR:

Diagnóstico y Tratamiento del Climaterio.

4.1 NOMBRE Y CÓDIGO:

Climaterio: CIE 10 N95.1

Perimenopausia: CIE 10 N95.9

4.2. PROCESO DE DESAROLLO DE LA GUIA

Esta guía se basa en el proceso de adaptación de guías de práctica clínica recomendado por el ministerio de salud (Ministerio de Salud 2015).

Para la elaboración de las preguntas clínicas se delimitó el ámbito de la guía específicamente al diagnóstico y manejo del climaterio. Luego de la formulación de las preguntas a resolver, se realizó una búsqueda sistemática de la literatura utilizando las bases de datos PUBMED y Scielo.

La estrategia de búsqueda utilizada en Pubmed fue la siguiente:("Climacteric"[Title/Abstract] AND hormone replacement therapy[Title/Abstract]) AND Practice Guideline[ptyp].

La estrategia de búsqueda en Scielo fue la siguiente:(*climacteric) AND (Non-hormonal therapies*) AND (Hormone replacement therapy*)

Adicionalmente se revisó la guía elaborada por la Sociedad Peruana de Climaterio. A partir de la búsqueda y priorizando, aquellas guías de práctica clínica de mayor calidad según el AGREE II(AGREE 2001) se identificó aquellas GPC más relevantes al problema.

Se identificaron 2 guías con recomendaciones explícitas sobre diagnóstico y tratamiento del climaterio. La evaluación de las guías de acuerdo al instrumento AGREE II mostro un mayor puntaje para la guía de la SOGIBA (2018);seguida de la guía de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica (2020), a partir de las cuales se adaptaron la mayor parte de las recomendaciones de este documento.

Cada una de las recomendaciones adaptadas se validó por consenso entre los miembros del comité de redacción. Las recomendaciones fueron enviadas para opinión y sugerencias de los médicos del servicio y departamentos, así como un revisor externo.

V. CONSIDERACIONES GENERALES.

El climaterio marca una fase significativa en la experiencia femenina, abarcando un período que incluye la transición hacia y desde la menopausia (la fecha de la última menstruación), debido al declive o cese de la función ovárica. Este período no solo implica transformaciones que se manifiestan como síntomas físicos, sino que también afecta aspectos emocionales y sociales.

En la actualidad, en la mayoría de los países, las mujeres tienen una expectativa de vida de alrededor de 80 años, lo que significa aproximadamente 30 años después de la menopausia. Esta tendencia hacia una mayor longevidad femenina se está haciendo más evidente con el tiempo. En Sudamérica, a principios de este siglo, la expectativa de vida de las mujeres superaba los 70 años, y desde el año 2020, la expectativa de vida de las mujeres peruanas ha superado los 75 años. Estas estadísticas sugieren que más de un tercio de la vida de una mujer peruana se vivirá después de la menopausia.

Durante el climaterio, las mujeres pueden experimentar el síndrome climatérico, el cual abarca una serie de síntomas que pueden perturbar diversos aspectos de su vida, como lo social, sexual, emocional y laboral. En otras palabras, este síndrome puede afectar prácticamente todos los aspectos de la vida de una mujer de manera transversal.

5.1 DEFINICIÓN

5.1.1 Menopausia

Etimológicamente proviene del griego menses: mes y pausis: cesar, detener opausa, por tanto, menopausia significa etimológicamente dejar de menstruar.

La menopausia es la última menstruación que tiene la mujer y el diagnóstico se establece retrospectivamente al no presentarse menstruaciones durante un año, constituye una falla ovárica primaria debido a depleción de folículos, por lo tanto, el ovario ya no responde a las hormonas hipofisarias (FSH-LH) y cesa la producción hormonal de estrógenos y progesterona.

5.1.2 Climaterio

El término "climaterio" procede de una palabra griega "Klimater" que significa escalón o peldaño. Etimológicamente significa periodo de transición desde la etapa reproductiva (premenopausia) hasta la etapa no reproductiva (postmenopausia).

La transición a la menopausia es un período de tiempo que antecede a la menopausia y que puede durar hasta 4 años. El inicio de las irregularidades menstruales, generalmente acompañado de síntomas vasomotores (SVM), síndrome genitourinario de la menopausia (SGM), así como trastornos del sueño y del humor en los últimos años de la vida reproductiva, ha sido considerado como el inicio del comienzo a la transición a la menopausia.

Se caracteriza por:

- Disminución de la actividad ovárica, con agotamiento folicular, disminución de los niveles de inhibina B, incremento de la hormona foliculoestimulante (FSH) y disminución del estradiol
- Sintomatología relacionada a la carencia estrogénica, influenciada asimismo por factores socioculturales y personales
- Disminución de la masa ósea
- Incremento del riesgo cardiovascular

5.1.3 Postmenopausia

Se refiere al lapso posterior a la menopausia y antes del inicio de la vejez, que ocurre aproximadamente alrededor de los 65 años. Durante esta fase es cuando suelen manifestarse muchas de las enfermedades crónicas y degenerativas que impactan a las mujeres.

5.1.4 Menopausia Prematura

Se trata de la menopausia que se manifiesta antes de los 40 años, más precisamente conocida como falla ovárica prematura. Esta condición suele estar asociada principalmente con factores hereditarios, ambientales, enfermedades autoinmunes, metabólicas, así como tratamientos como la radioterapia o quimioterapia para el cáncer. Su incidencia afecta aproximadamente al 1% de la población general.

5.2 ETIOLOGÍA

Los folículos humanos comienzan a desarrollarse hacia el cuarto mes de gestación, las células germinales migran hacia el reborde gonadal, se multiplican y alcanzan alrededor de 5 a 7 millones hacia el quinto mes de vida intrauterina, a partir de este momento se detiene la replicación y comienza a perderse folículos (atresia) y se reduce hasta cerca de 1 o 2 millones al nacer. En la mujer adulta, las células germinales pueden:

1. Permanecer en reposo
2. Continuar con su desarrollo y llegar a ovular,
3. Sufrir apoptosis, finalmente cuando la población de ovocitos se agota y ya no puede cumplirse el ciclo ovárico, entonces sobreviene la menopausia.

Es esencial recordar que el ovario es fundamental como fuente de óvulos y, en consecuencia, como productor de hormonas como estrógeno, progesterona y andrógenos en las mujeres en edad reproductiva. Aunque al inicio del climaterio el eje hipotálamo-hipófisis-ovario permanece intacto, la concentración de la hormona folículo-estimulante (FSH) comienza a aumentar debido a la falta de retroalimentación negativa por parte de los estrógenos. La disminución de la reserva folicular, especialmente de las células de la granulosa, resulta en una producción reducida de estrógenos e inhibina, lo que lleva a un aumento en la concentración de FSH. Durante los últimos años de la etapa reproductiva, se observan menstruaciones regulares junto con niveles elevados de FSH, mientras que la transición a la menopausia se caracteriza por concentraciones elevadas de FSH, ciclos menstruales de duración variable y la eventual ausencia de menstruación. En el período postmenopáusico, se manifiesta la amenorrea.

5.3 FISIOPATOLOGÍA

La fisiopatología exacta se desconoce y probablemente esté relacionada con múltiples factores. La transición a la menopausia coincide con el descenso de los niveles de estrógeno y se conoce que el tratamiento con estrógenos mejora y alivia los SMV. Sin embargo, no serían los únicos Involucrados ya que las mujeres jóvenes con amenorrea hipotalámica hipoestrogénica no sufren sofocos, como tampoco las niñas prepuberales.

Actualmente la teoría más aceptada es que los mecanismos termorreguladores cambian durante la transición a la menopausia generando un acortamiento de la zona termoneutral, volviéndola más sensible a los cambios. Pequeños aumentos de temperatura actúan como gatillo que causan el sofoco (vasodilatación y sudoración). Las fluctuaciones en la temperatura corporal central son más pronunciadas en mujeres posmenopáusicas en comparación con mujeres premenopáusicas.

Los neurotransmisores están involucrados en la regulación de la zona termoneutral: mientras que los niveles de estrógeno descienden, los niveles de norepinefrina aumentan, lo que genera un aumento de los receptores hipotalámicos de serotonina, generando un estrechamiento adicional de la zona termoneutral. El mecanismo exacto de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (IRSS) en el alivio de los SVM es desconocido, pero se cree que estaría relacionado con esta teoría. El incremento de la cantidad de receptores de serotonina genera un descenso de serotonina circulante a nivel cerebral. Cuando las mujeres utilizan IRSS, los niveles de serotonina cerebral aumentan, amplían la zona termoneutral y como consecuencia mejoran los SVM. El descenso estrogénico también estimula los receptores centrales alfa 2, lo que genera un aumento de los niveles de norepinefrina y como consecuencia, una reducción de la zona termoneutral.

5.4 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS

La edad de la menopausia parece estar genéticamente determinado y no es afectado por raza, edad de la menarquía, número de ovulaciones previas o estado socioeconómico. La edad promedio en que ocurre la menopausia varía en diferentes poblaciones, en Estados Unidos y Europa el promedio de edad es a los 51 años, en el Perú el promedio de edad de la menopausia está alrededor de los 47 años, pero en las mujeres que viven en la altura se presenta a menor edad, Cusco (3400 msnm) ocurre a los 45 años yen Cerro de Pasco (4300 msnm) se presenta a los 42 años.

5.5 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS:

5.5.1 MEDIO AMBIENTE

La altitud puede afectar la experiencia de la menopausia y la salud ósea de una mujer.

- Síntomas de la menopausia: Algunas mujeres pueden experimentar síntomas de la menopausia de manera diferente en altitudes más altas debido a la menor presión de oxígeno. Esto puede incluir cambios en la temperatura corporal, sudoración, fatiga y dificultad para dormir.

- Salud ósea: La altitud puede influir en la salud ósea debido a la menor disponibilidad de oxígeno. Esto puede ser relevante para las mujeres en la menopausia, ya que están en mayor riesgo de osteoporosis debido a la disminución de los niveles de estrógeno. La adaptación a la altitud puede requerir un esfuerzo adicional del cuerpo, lo que podría afectar la densidad ósea.
- Actividad física: En algunas áreas de alta altitud, la disponibilidad de actividades físicas al aire libre puede ser diferente. Esto puede influir en el bienestar general y la capacidad de mantener un estilo de vida activo durante la menopausia, lo que puede afectar la salud en general.

5.5.2 ESTILOS DE VIDA

Existen factores de riesgo asociados como la obesidad, depresión, ansiedad, bajo estatus socioeconómico y el tabaquismo.

5.5.3 FACTORES HEREDITARIOS

Existe evidencia de una predisposición genética ya que se han encontrado vínculos entre los síntomas y varios polimorfismos relacionados con el metabolismo de los esteroides sexuales.

VI. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

6.1 CUADRO CLÍNICO

6.1.1. SIGNOS Y SINTOMAS

1. Alteraciones menstruales

La variabilidad en el ciclo menstrual es común en todas las mujeres y cesa definitivamente con la interrupción permanente de la menstruación. Este fenómeno surge debido a la disminución de hormonas ováricas característica de esta etapa, así como a la anovulación crónica y la escasez de progesterona durante esta transición. Estos factores pueden resultar en períodos prolongados de exposición a los estrógenos sin contrarrestar, lo que puede ocasionar sangrado sin ovulación, provocado por el crecimiento excesivo del revestimiento uterino debido a la anovulación. Alternativamente, puede dar lugar a periodos de escasas menstruaciones, definidos como intervalos menstruales de más de 35 días. Estos episodios de sangrado irregular a menudo son motivo de monitoreo endometrial.

2. Síntomas vasomotores.

Los signos vasomotores (SVM), que incluyen sofocos y sudores tanto diurnos como nocturnos, son síntomas distintivos durante la transición a la menopausia y pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida: hasta el 80% de las mujeres experimentan SVM durante este período. Los SVM son la manifestación principal del climaterio; comienzan durante la transición a la menopausia y alcanzan su punto máximo aproximadamente 1 a 2 años después del cese del período menstrual. Sin embargo, su duración puede ser prolongada.

El estudio SWAN pudo ver que la duración de los SVM fue:

● Mayor en los siguientes casos:

○ Mujeres que iniciaron sus síntomas en la etapa premenopáusica o en la perimenopausia temprana (media 11.8 años)

○ Mujeres afroamericanas (media 10.1 años)

○ Mujeres jóvenes al iniciar los síntomas

○ Fumadoras y obesas

○ Mujeres con altos niveles de ansiedad, estrés y depresión.

● Menor en los siguientes casos:

○ Mujeres postmenopáusicas al inicio de la sintomatología (3.4 años)

○ Mujeres japonesas y chinas (4.8 y 5.4 años respectivamente)

○ Mujeres casadas o en pareja

○ Mujeres de mayor nivel educacional y con mayor soporte social.

El sofoco se describe como una sensación repentina de calor extremo en la parte superior del cuerpo, particularmente la cara, el cuello y el pecho. Estos episodios, que generalmente duran 1-5 minutos, se caracteriza por transpiración, enrojecimiento, escalofríos, ansiedad y, en ocasiones, palpitaciones. Los SVM también pueden interferir con el sueño y causar trastornos crónicos del sueño en algunas mujeres.

3. Sindrome genitourinario de la Menopausia (SGM)

Esta nueva terminología ha reemplazado a la clásicamente denominada "atrofia vulvo-vaginal" (AVV). Comprende a las modificaciones del aparato genital y urinario relacionadas con la deficiencia estrogénica. Se define como un conjunto de síntomas y signos asociados con la disminución de los estrógenos y otros esteroides sexuales, incluyendo cambios en los labios mayores y menores, vestíbulo, introito, vagina, uretra y vejiga. Actualmente el SGM se considera como una definición más correcta, comprensible y aceptable.

La atrofia vaginal asociada a hipoestrogenismo se hace clínicamente evidente luego de 4-5 años de menopausia, siendo la sequedad vaginal el primer síntoma referido. Otros síntomas incluyen irritación, picazón, flujo y, entre mujeres sexualmente activas, dispareunia y otras formas de disfunción sexual. Además, pueden coexistir síntomas urinarios tales como frecuencia, urgencia, nicturia, disuria, incontinencia e infecciones urinarias a repetición.

El SGM es crónico, progresivo y a diferencia de los SVM, no mejora con el tiempo. Se caracteriza por adelgazamiento del epitelio vulvovaginal y del tracto urinario inferior, con pérdida de la elasticidad vaginal asociado a escasa lubricación.

4. Enfermedades Cardiovasculares.

Las enfermedades cardiovasculares representan alrededor del 45% de las muertes en mujeres. Durante esta etapa, la preocupación cardiovascular se manifiesta en el diagnóstico de síndrome metabólico. Aquellas personas que lo padecen tienen tres veces más probabilidades de sufrir un infarto cardíaco o un accidente cerebrovascular, y el doble de probabilidades de fallecer a causa de una enfermedad vascular.

5. Osteoporosis

La osteoporosis implica una reducción en la fortaleza ósea, lo que resulta en una disminución tanto en la calidad como en la cantidad del tejido óseo, lo que lleva a una fragilidad ósea y un mayor riesgo de fracturas. Esta condición se vuelve más común con la edad, y las áreas más susceptibles son aquellas que contienen hueso trabecular, como la columna lumbar. Además, hay una asociación inversa entre el índice de masa corporal y la incidencia de osteoporosis.

6. Síntomas psicológicos y del estado de ánimo.

El riesgo de desarrollar un episodio de depresión mayor es 1.5 a 1.7 veces mayor en mujeres que en hombres; particularmente en los años reproductivos. La perimenopausia ha sido descrita como un período de especial vulnerabilidad, momento clave en el que recurren episodios depresivos y eventualmente la primera manifestación de un primer episodio de depresión. A pesar de la evidencia de una ventana crítica para el nuevo inicio de la depresión, un episodio depresivo previo (particularmente si se relaciona con eventos reproductivos) sigue siendo el predictor más importante para trastornos del estado de ánimo o depresión durante la peri y postmenopausia. Cerca del 75% de las mujeres perimenopáusicas refieren alteraciones del ánimo y del sueño. Los SVM, la ansiedad, trastornos del sueño y otros problemas relacionados con la salud también modulan el riesgo de depresión.

7. Sexualidad

En el año 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) redefine a la salud sexual como "Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud".

Si bien la definición es universal, la mujer atraviesa diferentes etapas a lo largo de su vida en donde se suman otros factores a tener en cuenta. La transición menopáusica, caracterizada por cambios hormonales, psicológicos y sociales, habitualmente se asocia con algún tipo de disfunción sexual.

La menopausia es percibida por muchas mujeres como el fin de la sexualidad, y no sólo como el fin de la vida reproductiva. Vale la pena destacar que la sexualidad femenina no sólo se caracteriza por el deseo y la actividad sexual per se, sino que es compleja, intrigante y compuesta por múltiples dominios, que si bien incluyen el deseo, la excitación y el orgasmo, está determinada por otros factores: la sensación de bienestar, los pensamientos y las emociones, que son fundamentales a la hora de encontrar razones que favorezcan las relaciones sexuales, y luego, desde allí, la receptividad para, ante estímulos apropiados, iniciar la actividad sexual

Factores potenciales que influyen en la disminución de la función sexual femenina en la postmenopausia podrían agruparse como:

● Factores psicosociales:

○ Actitudes previas hacia el sexo

○ Costumbres culturales y creencias religiosas en relación al sexo

○ Mala relación de pareja

○ Sentimientos hacia la pareja

○ Tiempo de la relación

○ Disminución de la actividad sexual de la pareja

○ Pérdida de interés por el sexo en la pareja

○ No tener pareja

○ Factores de estrés asociados al trabajo, relaciones familiares

○ Imagen corporal negativa

● Desórdenes psicológicos

○ Depresión

○ Ansiedad

○ Otras enfermedades psiquiátricas

● Problemas médicos

○ Menopausia

○ Atrofia vaginal

○ Síntomas vasomotores

○ Declinación en el deseo sexual en relación a la edad

○ Fatiga

○ Incontinencia

○ Enfermedades crónicas que incluyen: cardiovasculares, diabetes, artritis, falla renal, etc.

○ Cáncer ginecológico y especialmente cáncer de mama

● Agentes farmacológicos

○ Psicotrópicos: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, barbitúricos, ansiolíticos y sedantes

○ Cardiovasculares: betabloqueantes, clonidina, metildopa, espironolactona (que tiene propiedades anti androgénicas)

○ Hormonas: agonistas y antagonista de la hormona liberadora

de gonadotropinas, corticoides, anti-andrógenos

○ Otras: alcohol, marihuana, cocaína, heroína

6.1.2. INTERACCIÓN CRONOLÓGICA

Los criterios de STRAW+10 son una actualización de los criterios originales de la Sociedad Internacional de la Menopausia (International Menopause Society, IMS) y la Sociedad Norteamericana de Menopausia (North American Menopause Society, NAMS), conocidos como los criterios STRAW (Stages of Reproductive Aging Workshop).

Etapas del STRAW+10

Etapa -3: "Reproductiva tardía": se considera el momento en el que disminuye la tasa de fertilidad y la mujer empieza a notar cambios en su ciclo menstrual. Se divide en dos subetapas:

- -3b: caracterizado por ciclos regulares y estradiol y FSH normales, niveles de hormona antimulleriana (HAM) que comienzan a descender acompañado por la disminución en el número de folículos antrales.
- -3a: donde aparece el típico acortamiento de los ciclos, evidenciándose sangrado menstrual frecuente.

Etapa -2: "Transición temprana": se caracteriza por la variabilidad en la duración del sangrado menstrual entre ciclo y ciclo. Desde el punto de vista hormonal la FSH va aumentando y la HAM disminuyendo, lo mismo que el conteo de los folículos antrales. Determina el inicio de la "perimenopausia".

Etapa -1: "Transición tardía": Caracterizada por ausencia del sangrado menstrual durante más de 60 días; variabilidad en la duración del sangrado entre ciclo y ciclo, fluctuaciones hormonales y anovulación en forma frecuente. Generalmente se observa disminución de HAM y un incremento en los niveles de FSH ≥ de 25 UI/L. Dura aproximadamente entre 1 y 3 años. Es posible que se acompañe de SVM.

Etapa +1: Postmenopausia temprana: dura entre 5 y 8 años. Los niveles de FSH continúan aumentando y los de estradiol disminuyendo hasta aproximadamente 2 años luego del último sangrado menstrual. Este período se subdivide en 3 etapas:

- +1a: marca el fin de un período de 12 meses luego de la FUM, así como el fin de la "perimenopausia"
- +1b: rápido aumento de la FSH

Los estadíos +1a y +1b juntos duran aproximadamente 2 años. Es el período de tiempo donde habitualmente aparecen los SVM

- +1c: niveles estables de FSH y muy bajos de estradiol

Etapa +2: "Postmenopausia tardía": prácticamente ya no hay cambios en la función reproductiva. Se evidencian SGM.

Los criterios de STRAW+10 pueden ser utilizados en la mayoría de las mujeres. La evidencia sugiere que, si bien hay ciertos factores como el hábito de fumar, el índice de masa corporal y factores demográficos que influyen en la edad de la FUM, aunque ésta se modifique, no se altera la evolución típica para los diferentes eventos que STRAW+10 propone.

Las directrices del STRAW+10 recomiendan esperar al menos tres meses después de una

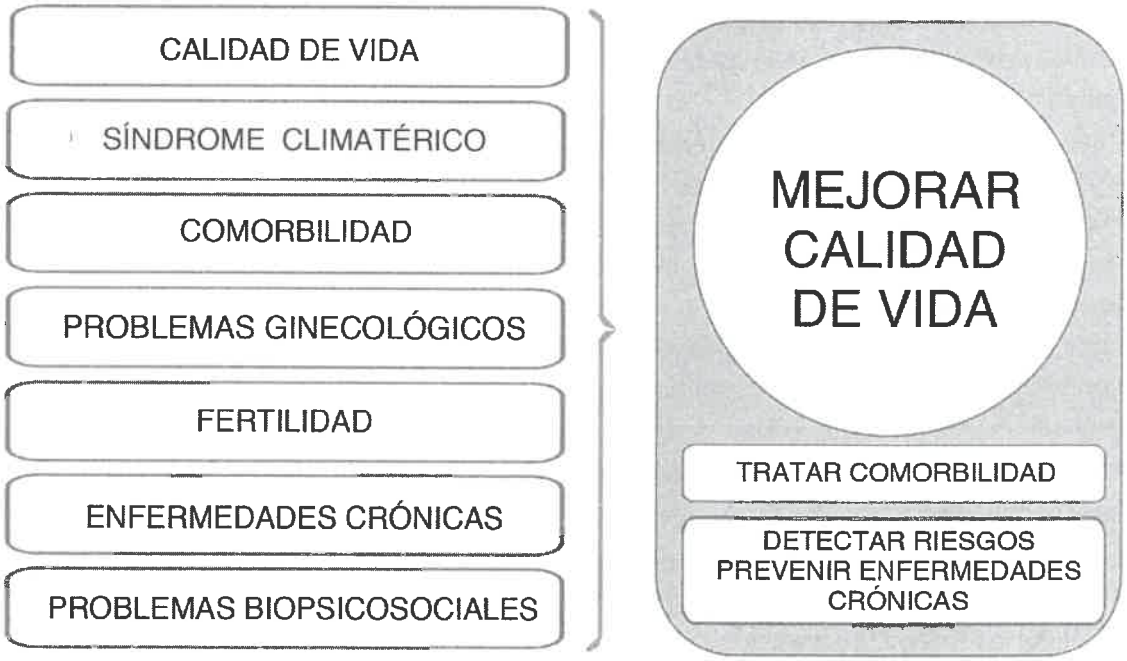
intervención quirúrgica para evaluar los criterios endocrinos, debido a que la evidencia sugiere que los niveles de FSH se elevan transitoriamente luego de la cirugía pélvica.

Mujeres en las que no debiera aplicarse STRAW+10:

- Insuficiencia ovárica primaria/precoz: la evolución puede modificarse de acuerdo con la causa e incluso muchas veces el diagnóstico no es definitivo.
- Histerectomizadas o sometidas a una ablación endometrial: ya que no se producen las modificaciones en el sangrado menstrual.
- Síndrome de ovario poliquístico: sangrado menstrual infrecuente que precede los cambios relacionados con la edad
- Amenorrea hipotalámica
- Bajo tratamiento con quimioterapia: cambios en los niveles de FSH de acuerdo con los agentes utilizados
- Bajo tratamiento con tamoxifeno: el tratamiento puede alterar los valores de FSH y estradiol
- HIV/SIDA: falta de fiabilidad en el patrón de sangrado y de valores de FSH y estradiol

6.1.3. GRÁFICOS, DIAGRAMAS, FOTOGRAFÍAS

Figura1. Principales objetivos clínicos en el manejo de la mujer en edad de climaterio.



Menarquia

FUM (0)

Estadio	-5	-4	-3b	-3a	-2	-1	+1a	+1b	+1c	+2
Terminología	REPRODUCTIVA				TRANSICIÓN MENOPÁUSICA		POSTMENOPAUSIA			
	Temprana	Media	Tardía		Temprana	Tardía	Temprana			Tardía
					Perimenopausia					
Duración	variable				variable	1 a 3 años	2 años (1+1)		3 a 6 años	Esperanza de vida restante
CRITERIO PRINCIPAL										
Ciclo menstrual	Variable a regular	Regular	Regular	Cambios sutiles en flujo/LEM GTH	Duración variable Persistente ≥ 7 días diferencia en duración en ciclos consecutivos	Intervalo de amenorrea de ≥ 60 días				
CRITERIOS DE APOYO										
Endocrino FSH AMH Inhibina B			Bajo Bajo	Variable Bajo Bajo	↑variable Bajo Bajo	↑>25 UI/L** Bajo Bajo	↑variable Bajo Bajo	Estabiliza Bajo Bajo		
Recuento de folículos antrales			Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Muy bajo	Muy bajo		
CARACTERÍSTICAS DESCRIPTIVAS										
Síntomas						Síntomas vasomotores probable	Síntomas vasomotores, muy probable			Aumento de síntomas de atrofia urogenital

** Sangre extraída los días 2-5 del ciclo ↑= el evado

** Nivel aproximado esperado basado en ensayos que utilizan estándares actuales internacionales de hipofisis**

Figura 2. STRAW Estadíos de Envejecimiento Reproductivo.

ESTRÓGENOS

DOSIS DIARIA	Dosis Baja	Moderada	Alta
Estrógenos conjugados equinos	0,3 - 0,45 mg	0,625 mg	1,25 mg
Estradiol micronizado o valerato	0,5 - 1 mg	1,5 mg	≥ 2 mg
Estradiol transdérmico gel	0,5 - 0,75 mg	1 mg	1,5 mg
Estadiol transdérmico aerosol	1,53 mg	3,16 mg	4,59 mg

PROGESTÁGENOS

DOSIS DIARIA	Dosis secuencial 10 a 14 días	Dosis continua	Disponible sola
Progesterona micronizada	200 mg	100 - 200 mg	si
Dihidrogesterona	10-20 mg	5-10 mg	si
Nomegestrol	5 - 10 mg	2,5 mg	si
Drospirenona	2 mg	2 mg	pronto
Trimegestona	0,25 mg	0,125 mg	no
Dienogest		2 mg	si
Desogestrel	0,150 mg	sin información	si
Noretisterona	0,5-1 mg	0,5 - 1 mg	no
Levonorgestrel	0.03 - 0,04	sin información	si
Clormadinona	10 mg	sin información	no
Medroxiprogesterona acetato	5 - 10 mg	2,5 mg	si
DIU-LNG	no aplica	3-5 años	

STEAR Y TSEC

STEAR	Tibolona	2,5 mg
TSEC	ECE + bazedoxifeno	0,45 + 20 mg

THM LOCAL GENITOURINARIA

DOSIS DIARIA	Dosis de carga	Mantención
Estradiol tabletas intravaginales de 10 µg	10 µg por noche por 10 -20 días	10 µg 2 - 3 veces por semana
Promestrieno óvulos 10 mg o crema 1%	10 mg o 1 aplicación por noche por 10 - 20 días	10 mg 1 - 3 veces por semana
Estriol óvulos 0,5 mg	0,5 mg pr noche por 10 - 20 días	0,5 mg 2 -3 veces por semana
Estriol crema 0,05% o 0,1%	1 aplicación diaria por 10 - 20 días	1 segmento 2 - 3 veces por semana
Estrógenos conjugados crema 0,0625% (0,625mg/g)	1 - 2 aplicaciones diarias por 10 - 20 días	1 segmento 2 - 3 veces por semana

Figura 3. Dosificaciones Diarias de TRH.

Figura 4. Metas en el manejo del riesgo metabólico, recursos de tratamiento y efecto de la TRH.

	HIPERTENSIÓN	FUMAR	DIABETES 2	OBESIDAD	DISLIPIDEMIA	SEDENTARISMO
METAS	<130/85	Cero No fumar	Hemoglobina glicada A1C <6,5%	Cintura <88 cm	ATP-III <3/5 Score CV < 7,5% a 10 años	Ejercicio 2,5 horas por semana o 30' diarios incluir ejercicios de potencia muscular
RECURSO PRINCIPAL	Estilo de vida	Decisión personal. Convicción de	Estilo de vida	Estilo de vida	Estilo de vida	Estilo de vida
FÁRMACOS	IECA*, ARA2**, Bloq. de canales de calcio, diuréticos, B-bloqueadores, otros	Vareniclina Bupropión	Metformina Glifozinas, Gliptinas, Glinidas, Análogos GLP-1 Insulinas	Orlistat, Locarserina, Fentermina Topiramato, Liraglutida, Ninguno de 1ª línea	Estatinas, Ezetimiba, Fibratos, Evolocumab	
EFECTO POTENCIAL DE THM	Puede reducir el uso de antihipertensivos	THM oral empeora riesgo cardiovascular	Hasta 20% menos incidencia de DM2	Menos obesidad abdominal	Mejor Colesterol HDL y LDL THM con E2 oral aumenta Triglicéridos	Animo. Masa muscular, estabilidad y coordinación. Reduce osteoporosis y fracturas
PRECAUCIONES	Hipertensión controlada antes de iniciar THM. Preferir E2 no oral + PM o fórmulas con drospirenona o trimegestona	Contraindicacion relativa TH oral, Considerar estatinas Calcular puntaje CV	Verificar existencia de ateromas	Preferir vía transdérmica por riesgos TVP	Individualizar THM con E2 no oral o tibolona en triglicéridos elevados	Preferible THM transdérmica en inmovilizados.

* Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ** Bloqueadores de angiotensina II.

DOMINIOS	THM	THM LOCAL	ALTERNATIVAS
Vasomotores	++++	-	Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (ISRS) +
Palpitaciones	++++	-	Betabloqueadores ++
Artralgias	+++	-	Antiinflamatorios no esteroidales +++
Insomnio	++	-	Trazodona, zolpidem, zopiclona +++ ; ISRS + Inhibidores H1 (quetiapina en dosis muy bajas) ++
Depresión	++	-	ISRS +++ ISR duales (Serotonina y noradrenalina) +++
Ansiedad, angustia	++	-	ISRS +++
Irritabilidad	++	-	ISRS +++
Olvidos	++	-	ISRS ?
Sexual	+	+	Andrógenos ++
Incontinencia	contradictorio	dudoso como terapia única	Musculatura de piso pélvico: kinesiterapia dirigida y/o ejercicios de Kegel. Vejiga hiperactiva: tolterodina, darifenacina, trospio, solifenacina.
Atrofia genital	++++	++++	Paliativos humectantes y lubricantes

Figura 5. Terapias disponibles para mejorar la calidad de vida relacionada con el climaterio.

SITUACIÓN CLÍNICA	CONDICIÓN	RECOMENDACIÓN
Tratamiento por síntomas según intensidad	MRS Total ≥ 15 puntos	THM muy recomendable.
	MRS Total ≥ 8 puntos MRS Somático ≥ 8 puntos MRS Psicológico ≥ 6 puntos MRS Urogenital ≥ 3 puntos	Cualquier THM según evaluación individual
Mujer sin comorbilidad	< 60 años	Cualquier TH con estrógenos sistémicos, tibolona, TSEC
	≥ 60 años	Evaluación previa especial, CV y de placa ATE inestable
Mujer obesa sana	IMC 30 a 40	Preferir E2 transdérmico o E2 oral dosis bajas; tibolona, TSEC
Mujer con hipertensión arterial	Hipertensión tratada cumple meta ≤ 130/85	Pudiendo usar cualquier TH, preferir E2 transdérmico + Progesterona micronizada, drospirenona o dihidrogesterona
	Hipertensión tratada con resultado insatisfactorio	Determinar causa endocrinológica o nefrológica del fracaso Optar por E2 TD + drospirenona, PM o dihidrogesterona
Mujer diabética	Con lípidos normales	Preferir E2 transdérmico u oral en dosis bajas, tibolona o TSEC
	Con hipertrigliceridemia	Preferir E2 transdérmico o tibolona, evitar estrógenos orales.
Antecedente de trombosis venosa	Dada de alta de episodio único de tromboembolía venosa	E2 transdérmico + Progesterona micronizada o Dihidrogesterona o THM con tibolona.
	Trombofilia o 2 episodios de tromboembolia venosa	E2 transdérmico + progesterona micronizada o dihidrogesterona; tibolona, con eventual uso de anticoagulante.
Antecedente CV arterial	Antecedente de IAM o AVE	No iniciar THM con estrógenos sistémicos, tibolona ni TSEC
Migraña	Sin aura	Cualquier THM sistémica continua y estable.
	Con aura	Estradiol transdérrmico continuo. Preferir P micronizada secuencial
Cirugía bariátrica	Cualquier tipo	Cualquier THM con estrógenos sistémicos; tibolona; TSEC.

Figura 6. Sugerencias en situaciones clínicas comunes. Parte I

SITUACIÓN CLÍNICA	CONDICIÓN	RECOMENDACIÓN
Síndrome premenstrual y síndrome disfórico PM	Antecedente de síntomas compatibles	THM continua + oposición con drospirenona, DHP o trimegestona. Evitar oposición con Progesterona, levonorgestrel y MPA
Síndrome urogenital	Sin contraindicación de THM sistémica	Cualquier THM sistémica y/o local, Estradiol, estriol, DHEA, promestrieno
	Con contraindicación de THM sistémica	Preferir promestrieno local
Disfunción sexual	Libido disminuida.	Peferir tibolona; cualquier THM con estrógenos sistémicos; TSEC; Puede asociar Testosterona o DHEA; Prasterona + Estradiol valerato
Depresión	MRS Psicológico ≥ 6 Depresión mayor	Cualquier THM con estrógenos sistémicos; tibolona; TSEC Tratamiento coordinado con psiquiatra con TH iniciada
Insomnio	Identificar subtipos y asociación con síntomas psicológicos.	Cualquier THM. Preferir E2 + progesterona micronizada nocturna Puede asociarse hipnóticos o trazodona
Endometriosis o ademeiosis	Por antecedente o síntomas remotos	Tibolona, TSEC o cualquier THM con oposición contínua o DIU-LNG
Osteopenia u osteoporosis	Diagnóstico por FRAX o DXA	Cualquier THM con estrógenos sistémicos; tibolona; TSEC
Tabaquismo	Por riesgo cardiovascular y de cáncer	THM transdérmica + oposición con PM o DHP. Tratar la adicción
Mastopatía benigna	MFQ o densificación mamaria a Rx	Tibolona, TSEC o cualquier THM sistémica
Cáncer de mama	Antecedente personal	No usar THM sistémica de ningún tipo
	Antecedente familiar	Puede usar cualquier THM sistémica. Tamizaje genético en casos índice
Cáncer de endometrio	Curadas en estadíos I y II	Preferir THM con progestágeno continuo
Otros cánceres	Ginecológicos y no ginecológicos	Considerar condición de receptores. Evitar en ER (+) o PR (+)
VIH	Portadora o con SIDA	Cualquier THM con estrógenos sistémicos; tibolona; TSEC

Figura 7. Sugerencias en situaciones clínicas comunes. Parte II

TRATAMIENTO	DOSIS DIARIA	COMENTARIOS
Escitalopram	10 mg	Eficacia 61%
Paroxetina	7,5 - 25 mg	Eficacia 18% [16]. Contraindicado en usuarias de tamoxifeno. Asociación con fracturas. [17]
Sertralina	50 mg	Eficacia 18% [16]
Venlafaxina	75 - 150 mg	Eficacia 15% [18]
Desvenlafaxina	50 - 200 mg	Eficacia 49% dosis 100 mg; 60 - 65% dosis ≥150 mg; riesgo hipertensivo. [19]
Isoflavona	100 mg	Eficacia 25 - 33% [20]
Vortioxetina	5 -20 mg	Evidencia en depresión mayor + síntomas climatéricos [26]
Pregabalina	75 - 300 mg	Eficacia hasta 50% (1 solo estudio). Rápido efecto
Gabapentina	300 - 900 mg	Eficacia 14,8%. Rápido efecto.
Clonidina	100 mg	Eficacia 14,8%. Rápido efecto. Puede causar hipotensión.
Bloqueo simpático (bupivacaina)		Siminar a paroxetina en cáncer de mama [21]. Superior a pregabalina 75 mg cada 12 horas [22]

Figura 8. Terapias no hormonales útiles para tratamiento de síntomas vasomotores.

6.2. DIAGNÓSTICO

6.2.1. Criterios de Diagnóstico clínico

El diagnóstico de Climaterio es fundamentalmente clínico. En base al promedio de grupos etarios:
Premenopausia generalmente se inicia entre los 35 a 45 años.
Menopausia: entre los 45 a 55 años.
Postmenopausia: hasta los 65 años.

El diagnostico de Menopausia es retrospectivo: se concluye que la mujer tuvo su menopausia luego de 12 meses de amenorrea desde el último período menstrual, sin ninguna otra causa patológica o fisiológica.

6.2.2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Si bien la anamnesis y el examen clínico pueden ser muy sugerentes de que la paciente se encuentra en etapa de climaterio, es necesario evaluar otras patologías frecuentes en esta etapa.

1. Patología tiroidea: hiper e hipotiroidismo
2. Patología cardiovascular.
3. Problemas psicológicos: especialmente ansiedad y depresión.

6.3. EXÁMENES AUXILIARES

6.3.1. DE PATOLOGÍA CLÍNICA

Solicitar:

- Hemograma
- Hemoglobina glicosilada

- TGO
- TGP
- Hormona estimulante del folículo (FSH)
- Estradiol
- Inhibina B
- Glucosa sérica.
- Perfil de lípidos
- Examen de orina
- TSH

6.3.2. DE IMÁGENES

1. Ecografía

La ecografía ginecológica endovaginal es la prueba más asequible y de mayor utilidad para evaluar la pelvis y descartar patología uterina u ovárica concomitante. En la paciente climatérica y postmenopáusica está indicada para monitorizar el endometrio. En la paciente postmenopáusica en la que se realiza ecografia transvaginal, el grosor del endometrio debe ser menor o igual a 3mm. En la paciente que recibe terapia hormonal menopáusica el grosor endometrial debe ser menor o igual a 8mm.

2. Mamografía

La mamografía es el método de imagen más utilizado tanto en el estudio de las pacientes con síntomas mamarios, así como en pacientes asintomáticas, tiene como finalidad diagnosticar el cáncer de mama en estadios iniciales, es un método de imagen que conlleva radiación ionizante y necesita compresión de la mama para conseguir estudios de calidad. El estudio convencional consta de dos proyecciones de cada mama, una cráneo-caudal (CC) y otra oblicua mediolateral (OML), la realización de dos proyecciones en cada mama es fundamental para no pasar por alto lesiones visualizadas en una sola proyección, así como para realizar una correcta localización de las mismas.

La sensibilidad de la mamografía para diagnosticar cáncer de mama oscila entre el 61, 69 y el 95%, siendo inferior en pacientes con mamas densas, donde se estima que aproximadamente el 10% de los tumores no son visibles en la mamografía, incluso aunque sean palpables, su especifcidad oscila entre el 80- 90%, tanto la sensibilidad como al especificidad aumentan con la edad, siendo superiores en pacientes por encima de los 50 años. La mamografía digital presenta una serie de ventajas sobre la mamografía convencional: mejor resolución de contraste manteniendo un buen rango dinámico, fácil almacenamiento y disponibilidad de imágenes previas, posibilidad de envió de imágenes a otros centros para consulta o informe a distancia (telemamografia), posibilidad de manipulación para mejorar la imagen, eliminación de posibles artefactos de la placa, rapidez del procedimiento y menor dosis de radiación.
Se debe iniciar el examen a toda mujer a partir de los 40 años y repetir cada año, en mujeres con factores de riesgo alto para cáncer de mama, se debe iniciar a los 35 años.

Debe solicitarse juntamente con la ecografía de mamas para mejorar el diagnóstico precoz de cáncer de mama.

3. Densitometría ósea

La densidad mineral ósea (DMO) se utiliza para diagnosticar osteoporosis, de esta forma determinar el riesgo de fractura e identificar las mujeres que se beneficiarían de intervenciones terapéuticas. La DMO de doble absorciometría de rayos X(DEXA), es la principal técnica para la evaluación de la DMO, se expresa como (T-score), que es el número de desviaciones estándar de la media para una mujer joven y sana. Una puntuación T por encima de 1- se considera normal, un valor entre 1- y -2,5 señala osteopenia y una puntuación por debajo de -2,5 indica osteoporosis, se debe indicar a toda paciente menopáusica con factor de riesgo.

6.3.3. DE EXAMANES ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARIOS

Anatomía Patológica:

1. Papanicolau.

El cáncer de cuello uterino, o cáncer de cérvix, es causado por infección transmitida sexualmente por tipos oncogénicos del virus del papiloma humano, o VPH, denominados de alto riesgo. Hay catorce tipos de VPH de alto riesgo y solo dos de esos tipos, los VPH tipos 18 y 18, son responsables de cerca de 70% de todos los 3 cánceres de cuello uterino.

El examen de Papanicolaou detecta cambios en las células del cuello uterino que indican la presencia o que en el futuro podría formarse cáncer. Es por ello por lo que debe realizarse este estudio, a toda paciente que acuda al consultorio como parte de la evaluación epidemiológica anual. La prevención de esta patología es importante, por ser altamente frecuente en nuestro medio.

2. Biopsia de endometrio.

La biopsia de endometrio es el estándar para descartar la aparición de hiperplasia o cáncer endometrial, se puede realizar con cureta de Novak o por aspiración endometrial con cánula de Pipelle, este procedimiento tiene una sensibilidad de 73% y especificidad de 100% para la enfermedad endometrial. Está indicado en todas las pacientes climatéricas y postmenopáusicas que acuden por hemorragia uterina anormal en las que se sospeche altas probabilidades de hiperplasia o cáncer de endometrio.

6.4 MANEJO SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y CAPACIDAD RESOLUTIVA

6.4.1 MEDIDAS GENERALES Y PREVENTIVAS

6.4.1.1 Cambios del estilo de vida.

1. Dieta.

Se debe favorecer la dieta mediterránea a predominio de legumbres, frutas, verduras, semillas, granos, huevos, productos lácteos, pescado y aceite de oliva.

Aquellas mujeres que presentan un índice de masa corporal (IMC) elevado deberían recibir un plan de tratamiento consistente con el manejo integral de la mujer en edad de climaterio, que

incluya una pauta de alimentación, ejercicios y educación, de calidad tal que permita a la mujer establecer metas realistas que pueda cumplir con autonomía.

Promover la ingesta adecuada de calcio 600 – 1.200 mg/ día, que puede provenir de la dieta más suplementos y suficiente vitamina D (800 – 4.000 UI/día).

2. Ejercicio

Las mujeres en el climaterio deben realizar actividad física regular al aire libre, el ejercicio aeróbico durante toda su vida. El beneficio fundamental demostrados en muchos estudios y ensayos clínicos y metaanálisis es en la salud cardiovascular.

Se recomienda 150 minutos de ejercicio moderado/intenso a la semana o 30 minutos diarios.

También puede disminuir los síntomas típicos de la menopausia, especialmente los sudores nocturnos, los cambios de humor y la irritabilidad. El ejercicio aumenta la producción hipotalámica de B-endorfinas, el cual estabiliza la termorregulación que estaría alterada en las mujeres climatéricas con síntomas vasomotores.

Es probable que la actividad física se asocie con menor riesgo de cáncer de mama, a través de múltiples vías biológicas relacionadas entre sí, que pueden implicar la adiposidad, hormonas sexuales, resistencia a la insulina, adipocinas e inflamación crónica, la restricción calórica y la pérdida de peso con o sin ejercicio, reduce los biomarcadores de inflamación en mujeres posmenopáusicas, con significación clínica potencial para la reducción del riesgo de cáncer.

En caso de condiciones de riesgo relacionados con osteosarcopenia, es recomendable la evaluación previa por reumatólogo o endocrinólogo y geriatra en la mujer mayor. Ante eventuales riesgos de lesión osteoesquelética por condiciones basales de la mujer, es recomendable realizar una evaluación previa y un plan de actividad guiada por fisiatra, kinesiólogo, y/o médicos del deporte).

3. Retiro de hábitos nocivos.

Es importante que las mujeres dejen de lado hábitos nocivos, como el fumar, beber alcohol u otras drogas psicodélicas o fármacos sin indicación médica.

4. Autorrealización

Descansar lo suficiente, controlar el estrés y tomarse tiempo para disfrutar de la familia, los amigos y afianzar las redes de apoyo interpersonal. También se debería recomendar la realización de actividades mentalmente estimulantes.

6.4.1.2 Prevención de enfermedades

1. Sistema Cardiovascular

Aplicar criterios Adult Treatment Panel III (ATP-III) para detectar población de riesgo.

La mujer con síndrome metabólico debe recibir consejería y orientación sobre estilo de vida saludable, especialmente en dieta y ejercicio, fijando metas en sus parámetros metabólicos. Dependiendo de la severidad y pesquisa de patologías puede requerir tratamiento farmacológico que puede ser indicado por el tratante capacitado o con el apoyo de especialistas (médico familiar, internista, cardiólogo, endocrinólogo, diabetólogo, nutriólogo y nutricionista). Se debería definir el riesgo cardiovascular a 10 años, calculado por la escala de American College of Cardiology (ACC) y American Heart Association (AHA) sucesor de escala Framingham.
Puntos clave:

- Normalizar el peso corporal.
- Mantener normotensión.
- Conservar la glicemia en rangos normales.
- Mantener los lípidos en los márgenes ATP-III.
- No fumar.
- Mantener buena masa muscular y con actividad.

2. Detección temprana de cánceres

Los cánceres que causan mayor mortalidad en la mujer son: cáncer de mama, vesícula, estómago, tráquea-bronquiospulmón, colon y cérvicouterino.

3. Depresión

Durante las etapas de cambio hormonal como el climaterio, la mujer es más propensa a desarrollar depresión. La prevalencia de síntomas depresivos en mujeres de 45-64 años es del 30,1%. Se sugiere derivar a salud mental a todas las mujeres que presentan alterado el dominio sicológico de la encuesta MRS (≥ 6 puntos).

4. Salud músculo-esquelética

Los dolores musculares y articulares son síntomas muy frecuentes y persistentes en la pre y posmenopausia. Se asocian al déficit de estrógenos y a la aparición y progreso de la osteoartritis, antes conocida como artrosis. En este contexto, no es necesaria la evaluación rutinaria por reumatólogo, traumatólogo y/o endocrinólogo.
La TRH puede disminuir o eliminar estas molestias.

En caso de no poder usarla por contraindicación o ante la respuesta insuficiente a tratamiento, se puede considerar el uso prudente de antiinflamatorios no esteroidales y se recomienda el apoyo por reumatólogo.

El ejercicio regular y la alimentación con al menos 1 gramo de proteínas por kilo de peso al día contribuyen a reducir el riesgo de sarcopenia y osteosarcopenia, que prevalece en 6% de las mujeres de 60-65 años.

5. Prevención primaria de osteopenia y osteoporosis

Se debería recomendar suficiente calcio, 1.200 mg diarios a través de la alimentación o suplementos, y al menos 800 UI diarias de vitamina D. Promover ejercicios que favorezcan la

remodelación ósea y prevengan la sarcopenia 76, que estimulen el equilibrio, graduando la intensidad y la carga de forma progresiva. La TRH previene la osteopenia.

6.4.2. TERAPEÚTICO

INDIVIDUALIZACIÓN

La administración de THM de manera individualizada (incluyendo preparaciones androgénicas cuando fuese apropiado) puede mejorar la sexualidad y la calidad de vida en general.

La THM debe ser individualizada y confeccionada de acuerdo con los síntomas y a las necesidades de prevención, los antecedentes personales y familiares, el resultado de los estudios pertinentes, y las preferencias y las expectativas de la mujer.

En aquellas pacientes que cumplan con los preceptos anteriores y realmente lo necesiten.

6.4.2.1 TRATAMIENTO HORMONAL

Solo se debe prescribir en pacientes con síndrome climatérico. Es decir, en pacientes con síntomas entre moderados a severos. Nunca en leves.

EXISTEN DOS TIPOS DE THM.

- Sistémica: Solo en síndrome climatérico.
- Local: Cuando el único síntoma es la atrofia Urogenital.

Condiciones básicas para iniciar THM:

En sintomáticas con afectación de su calidad de vida (síndrome climatérico) Adecuada evaluación riesgos/beneficios.

- Dosis bajas.
- Tiempo corto,
- Individualizadas.
- Seguimiento periódicos.

Los Estrógenos no producen cáncer, pero, si los promueven.

El estrógeno es Mitogénico, No Mutagénico.

INDICACIONES DE TERAPIA HORMONAL MENOPAUSICA (THM)

TERAPIA SISTÉMICA de ESTRÓGENOS (formulaciones orales, transdérmicas y vaginales de dosis alta)

Las indicaciones para los problemas de la menopausia incluyen:

• Tratamiento de los síntomas vasomotores de la menopausia

• Tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia (anteriormente conocido como atrofia vaginal y vulvar)

• Prevención de la osteoporosis en las mujeres con alto riesgo de fractura osteoporótica que no pueden tolerar los medicamentos preventivos estándar

Las indicaciones aprobadas por la FDA para los progestágenos incluyen:

• Amenorrea, ya sea primaria o secundaria

• Tratamiento de fertilizacion reproductiva asistida

• Hiperplasia endometrial

• Sangrado uterino disfuncional

El término: terapia de reemplazo hormonal (TRH) usado por mucho tiempo, ha sido actualmente modificada con una nueva terminología denominada: "terapia hormonal menopáusica" (THM). Se debe iniciar THM a la paciente que cumpla con los criterios generales de prescripción, la relación riesgo / beneficio es más favorable en mujeres posmenopáusicas jóvenes que comienzan la THM antes de los 60 años o dentro de los 10 años desde la menopausia, en general no existe una formulación terapéutica única que sea ideal para todas las mujeres y todas las edades, cada producto o combinación puede tener características peculiares y pueden ser consideradas en un contexto personalizado: "Manejo individualizado", de esta forma se permite monitoreo dinámico, eligiendo tipo de estrógeno y progestina, dosis de cada uno, vía de administración, de acuerdo con las características y preferencias de cada paciente, para obtener la mejor eficacia maximizando la seguridad de la prescripción.

CONTRAINDICACIONES:
ABSOLUTAS:

•Sangrado vaginal sin explicación

•Disfunción o enfermedad hepática

•Historia de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar

•Trastorno de coagulación conocido o trombofilia (la presentación transdérmica puede ser una opción en algunas mujeres con riesgo elevado de trombosis venosa)

•Hipertensión no tratada

•Historia de cáncer de mama, endometrio u otra neoplasia estrogenodependiente

•Hipersensibilidad conocida a terapia hormonal

•Historia de Enfermedad Coronaria, ACV o AIT.

Se debe prescribir terapia progestacional concomitante cuando el u´tero esté presente.

RELATIVAS:

•Triglicéridos altos (superiores a 400 mg/dL)

•Enfermedad de la vesícula biliar (deben evitarse los estrógenos orales pero el estrógeno transdérmico puede ser una opción)

•Riesgo elevado de cáncer de mama (riesgo de cáncer a 5 años mayor de 5% por evaluación del NCI o IBIS) NCI, Instituto Nacional del Cáncer; IBIS, Estudio Internacional de Intervención

Cáncer de Mama)

•Estas contraindicaciones no se aplican a las terapias basadas en estrógenos transvaginales, ya que la concentración sérica de estrógenos de esta ruta es extremadamente baja. La North American Menopause Society (NAMS) ha recomendado que la advertencia que se aplica a la THM convencional no se aplique a los tratamientos de estrógenos transvaginales.

ELECCIÓN DE LA TERAPIA HORMONAL EN MENOPAUSIA

La THM de elección en mujeres sanas, perimenopáusicas y posmenopáusicas dentro de los 10 años de ocurrencia de su menopausia (o con edad < 60 años), que presenten síntomas vasomotores moderados a severos, mujeres sintomáticas con alto riesgo de osteoporosis, y mujeres que han experimentado una falla ovárica prematura, considerado como ventana de oportunidad terapéutica. Para elegir el tratamiento más adecuado se requieren al menos dos disquisiciones mayores: distinguir a las mujeres que tienen contraindicaciones de terapia oral y aquellas que tienen útero de las que no la tienen.

En mujeres sin contraindicaciones de terapia oral, disponemos las siguientes hormonas:

Estrógenos:

- Valerato de Estradiol 1mg/día
- 17-B-estradiol 1mg/día
- estrógenos conjugados 0,3-0,45 mg/día.

Vía transdérmica en pacientes con contraindicaciones de vía oral, se utiliza:

- Estradiol gel 0,5 a 1,5mg/día
- Estradiol aerosol 1.53mg/dia

Si la mujer tiene útero es imprescindible la adición de una progestina:

- cíclica (10 a 14 días)
- continua

Progestinas: Se encuentra en presentaciones orales, parenteral, transdérmicas, endoceptivas.

Opciones orales:

- Progesterona micronizada: continuo: 100mg/día o cíclico: 200 mg/día por 10 a 14 días.
- Drospirenona 2mg/día.
- Didrogesterona 5mg/día.
- Dienogest 2mg/día.
- Acetato de Medroxiprogesterona 5mg/día

Opciones transdérmica:

- Levonorgestrel 10 ug /día.
- Noretisterona 250ug/día

Opción endoceptiva: (SIU o DIU)

- Levonorgestrel 20ug. Liberados/24 hrs

Combinaciones de Estrógenos + Progestinas continuas:

- 17-B-estradiol 1mg+ drosperinona 2mg.
- Estradiol 1mg+didrogesterona 5mg.
- Valerato de estradiol 1mg + dienogest 2mg

Tibolona: A dosis 2,5 mg/día o 1,25 mg/día.

Estrógeno equino conjugado + Bazedoxifeno: Para mujeres con problemas de sensibilidad en las mamas, densidad mamaria, o sangrado uterino con THM convencional. Dosis: EC 0,45 mg/día + BZA 20mg/día

Ospemifeno: SERM 60 mg/día, para tratamiento de síntomas genitourinarios de la menopausia, incluyendo sequedad vaginal y dispareunia, entre mujeres que prefieren tratamiento oral.

Andrógenos

• Hay evidencia que indica que el uso de testosterona puede ser u ´til para mujeres con desorden de interés sexual y sin otra causa demostrable.

• Cuando se usa testosterona hay que controlar efectos adversos como, acné, cambios en el pelo, lípidos y función hepática.

• Los riesgos a largo plazo, cardiovascular y sobre la mama, de la terapia con andrógenos son desconocidos.

6.4.2.2 TRATAMIENTO NO HORMONAL

El tratamiento no hormonal incluye

a. Fitoestrógenos.
Las isoflavonas, son los fitoestrógenos más estudiados, han mostrado resultados en la reducción de la sintomatología vasomotora, el mayor consumo de fitoestrógenos entre mujeres de origen asiático en quienes se presenta el síndrome climatérico con menor frecuencia y menor severidad ha llevado a evaluar la posible eficacia de los fitoestrógenos en las mujeres postmenopáusicas.
b. Vitamina E.
c. Cionidina.
d. Cimicifuga racemosa (Black cohosh).
e. Ginseng (Panax ginseng).
f. B-sitosterol +glucosinolatos +citroflavonoides.

Tratamientos Alternativos,
Incluyen: Relajación, acupuntura, reflexoterapia, magnetoterapia y otros, todos sin estudios controlados.

6.4.3 EFECTOS ADVERSOS O COLATERALES CON EL TRATAMIENTO

El tratamiento con estrógenos puede producir sangrado uterino anormal al inicio como efecto adverso, siempre hay que descartar la posibilidad de una neoplasia en estos casos.

El cáncer de mama es un efecto a largo plazo que puede ocasionar, por eso periódicamente (anual) se debe evaluar con una mamografía.

6.4.4. SIGNOS DE ALARMA

El principal riesgo de la THM oral es la enfermedad tromboembólica, pero las terapias con estrógenos transdérmicos o tibolona oral muestran riesgo igual a controles sin THM.

El riesgo de cáncer de endometrio que se asoció a uso crónico de estrógenos sin oposición, se evita eficientemente con cualquier progestágeno aprobado. La evidencia disponible no muestra aumento del riesgo de incidencia de cáncer de mama asociado al uso de THM. Si bien el primer análisis del estudio WHI describió aumento de la incidencia de cáncer de mama cuando se cumplen 5 años de uso de la combinación ECE+MPA, este riesgo no se observó en estrógenos solos e incluso se redujo. Estudios de cohorte en Europa han mostrado que no hay asociación significativa entre estrógenos y riesgo de cáncer de mama pero si con progestinas norderivadas. La progesterona micronizada y dihidrogesterona no aumentan el riesgo.

6.4.5. CRITERIOS DE ALTA

El criterio para dar de alta a un paciente con tratamiento del climaterio depende de varios factores, incluyendo la respuesta al tratamiento, la estabilidad clínica y la ausencia de complicaciones.

- Estabilidad de los síntomas: Los síntomas del climaterio, como los sofocos, la sequedad vaginal, los cambios de humor, entre otros, deben estar bajo control y no estar causando una interferencia significativa en la calidad de vida del paciente.
- Adecuada respuesta al tratamiento: El paciente debe estar experimentando una mejoría en sus síntomas con el tratamiento prescrito, ya sea mediante terapia hormonal o terapias alternativas, y no presentar efectos secundarios significativos.
- Evaluación de riesgos y beneficios: Se debe haber discutido con el paciente los riesgos y beneficios del tratamiento hormonal o de otras opciones terapéuticas, y ambos deben estar de acuerdo con el plan de manejo.
- Seguimiento adecuado: Se debe haber establecido un plan de seguimiento con el paciente para monitorear su respuesta al tratamiento, así como para evaluar cualquier cambio en su estado de salud o en sus necesidades terapéuticas.
- Educación del paciente: El paciente debe estar bien informado sobre su condición, el tratamiento recibido y las medidas de autocuidado que puede seguir para mejorar su bienestar durante el climaterio.
- Continuidad de la atención: Se debe asegurar que el paciente tenga acceso continuo a la atención médica y recursos de apoyo necesarios después del alta, ya sea a través de consultas de seguimiento regulares o de recursos comunitarios.

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE · DIRECCIÓN GENERAL · DR. MOISES ENRIQUE TAMAYO ACOSTA · V°B°
HOSPITAL NAC. HIPÓLITO UNANUE · JEFATURA · GINECO-OBSTETRICIA

6.4.6. PRONÓSTICO

La calidad de vida de la mujer a partir de los 40 años depende directamente del grado de educación que le permita mantener una buena salud física y mental, la práctica de hábitos saludables, el acceder a tratamientos para conservar la salud y el soporte social de la familia y amistades, también es importante recibir información veraz y oportuna.

6.5. COMPLICACIONES

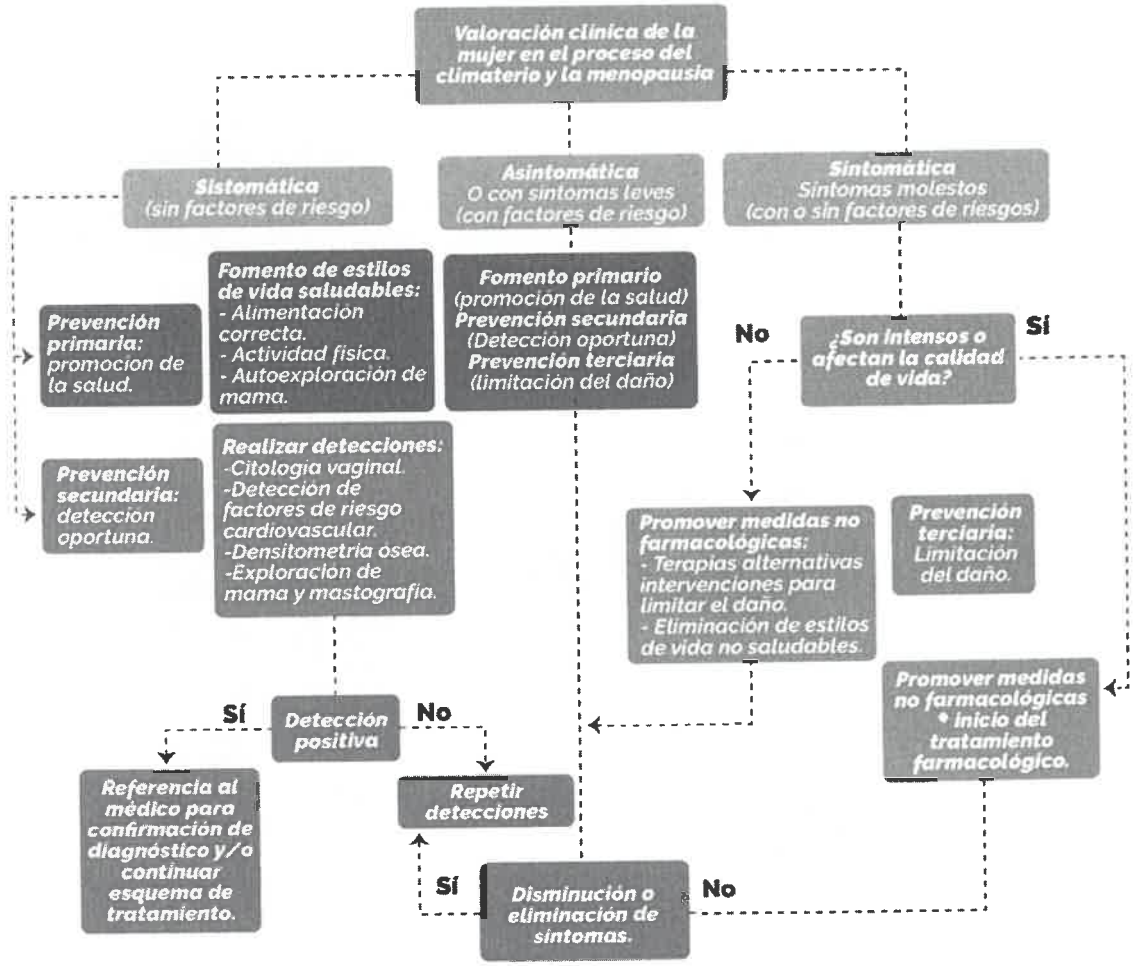
El tratamiento del climaterio, especialmente cuando implica el uso de terapia hormonal, puede estar asociado con ciertas complicaciones y riesgos

- Riesgo de trombosis: La terapia hormonal, especialmente cuando se administra en forma oral, puede aumentar el riesgo de trombosis, lo que puede llevar a condiciones graves como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar.
- Riesgo cardiovascular: Existe cierta evidencia que sugiere que la terapia hormonal puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, especialmente en mujeres mayores de 60 años o con factores de riesgo preexistentes.
- Cáncer de mama: El uso prolongado de terapia hormonal combinada (estrógeno y progesterona) puede aumentar ligeramente el riesgo de cáncer de mama. Este riesgo parece disminuir después de suspender la terapia hormonal.
- Cáncer de endometrio: El uso de estrógeno sin progesterona en mujeres con útero intacto puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio. Por esta razón, se recomienda el uso de terapia hormonal combinada en mujeres con útero intacto.
- Cambios en el tejido mamario: La terapia hormonal puede causar cambios en el tejido mamario que pueden hacer que las mamografías sean más difíciles de interpretar, lo que puede llevar a una mayor necesidad de pruebas de seguimiento.
- Efectos secundarios: Además de las complicaciones graves mencionadas anteriormente, la terapia hormonal puede causar efectos secundarios más leves, como sensibilidad mamaria, hinchazón, cambios en el estado de ánimo, dolores de cabeza y náuseas.

6.6. CRITERIOS DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA:

El hospital Nacional Hipólito Unanue es un centro de referencia nacional para patologías ginecológicas complejas, actualmente cuenta con una unidad de Menopausia, por lo que está en capacidad de realizar el manejo adecuado de la paciente en etapa de climaterio y menopausia.

6.7. FLUXOGRAMA


Valoración clínica de la mujer en el proceso del climaterio y la menopausia
Sistomática (sin factores de riesgo)
Asintomática O con síntomas leves (con factores de riesgo)
Sintomática Síntomas molestos (con o sin factores de riesgos)
Prevención primaria: promoción de la salud.
Fomento de estilos de vida saludables: - Alimentación correcta. - Actividad física. - Autoexploración de mama.
Fomento primario (promoción de la salud) Prevención secundaria (Detección oportuna) Prevención terciaria (limitación del daño)
No
¿Son intensos o afectan la calidad de vida?
Sí
Prevención secundaria: detección oportuna.
Realizar detecciones: -Citología vaginal. -Detección de factores de riesgo cardiovascular. -Densitometría ósea. -Exploración de mama y mastografía.
Promover medidas no farmacológicas: - Terapias alternativas intervenciones para limitar el daño. - Eliminación de estilos de vida no saludables.
Prevención terciaria: Limitación del daño.
Promover medidas no farmacológicas + inicio del tratamiento farmacológico.
Sí
Detección positiva
No
Referencia al médico para confirmación de diagnóstico y/o continuar esquema de tratamiento.
Repetir detecciones
Sí
Disminución o eliminación de síntomas.
No

VII. ANEXOS

ANEXO 1: Escala de puntuación en menopausia (MRS)

Nombre **Fecha**

¿Cuál de las siguientes molestias siente en la actualidad y con qué intensidad?
Marque solamente una casilla en cada uno de los 11 grupos de síntomas

		No siente molestia	Siente molestia leve	Siente Molestia moderada	Siente molestia importante	Siente demasiada molestia
		0	1	2	3	4
1	Bochornos, sudoración, calores.					
2	Molestias al corazón (sentir latidos del corazón, palpitaciones, opresión al pecho).					
3	Molestias musculares y articulares (dolores de huesos y articulaciones, dolores reumáticos).					
4	Dificultades en el sueño (insomnio, duerme poco).					
5	Estado de ánimo depresivo (sentirse deprimida, decaída, triste a punto de llorar, sin ganas de vivir).					
6	Irritabilidad (sentirse tensa, explota fácil, sentirse rabiosa, sentirse intolerante).					
7	Ansiedad (sentirse angustiada, temerosa, inquieta, tendencia al pánico).					
8	Cansancio físico y mental (rinde menos, se cansa fácil, olvidos frecuentes, mala memoria, le cuesta concentrarse)					
9	Problemas sexuales (menos ganas de sexo, menor frecuencia de relaciones sexuales, menor satisfacción sexual).					
10	Problemas con la orina (problemas al orinar, orina más veces, urgencia al orinar, se le escapa la orina).					
11	Sequedad vaginal (sensación de genitales secos, malestar o ardor en los genitales malestar o dolor con las relaciones sexuales).					

	Somático (1 al 4)	Psicológico (5 al 8)	Urogenital (9 al 11)		TOTAL (1 al 11)
Uso del profesional				=	

ANEXO 2: Evaluación de Experto

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

EVALUACION DE LA GPC POR GINECOLGO OBSTETRA

OBSERVACIONES DE LA GUIA PRÁCTICA CLÍNICA PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CLIMATERIO

- El transtorno del sueño en la paciente Climatérica es muy frecuente y repercute en su estado del animo, trabajo , relación con su familia entre otros ; por lo que el uso de benzodiacepinas para mejorar el descanso nocturno las puede llevar al uso crónico de las mismas. Existen otras alternativas como la melatonina que podria ser incluidas en la terapueútica y no crean dependencia.

- En pacientes con sintomas minimos de climaterio al rededor de 40 años (etapa 3) la prueba disagnostica de elecccion seria la HAM se realizaria de rutina en esos casos para ello se debe contar con la infraestructura en el hospital ya que de manera privada los costos son muy altos.

- La sintomatolgia urinaria mas frecuente es la urgencia, la guia deberia contemplar la evalucion previa por urologia antes de iniciar medicacion.

- Si se considera tratamiento no hormonal con fito estrogenos la guia debe contemplar la dosis terapeutica, el tiempo de uso y su efectividad.

- La obesidad morbida podria considerarse como contraidicacion relativa para THM

- Debe considerarse medicacion antiresortiva (con bifosfonatos permitidos) junto al calcio y vitamina D en la prevencion de osteoporosis.

Atte.

Dr. Richard F. Corzo Argüelles
GINECÓLOGO - OBSTETRA
CMP 38130 RNE: 21551
Hospital II Ramón Castilla
Red Asistencial Almenara
EsSalud

V°B°
M.C. MOISES ENRIQUE TAMBORINI ACOSTA
DIRECCIÓN GENERAL

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE
JEFATURA
DPTO. GINECO-OBSTETRICIA - MSN

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. R. J. Baber, N. Panay & A. Fenton the IMS Writing Group (2016): 2016 IMS. Recommendations on women's
2. midlife health and menopause hormone therapy, Climacteric, DOI: 10.3109/13697137.2015.1129166.
3. Harlow SD, Gass M, Hall JE, et al. Executive Summary: Stages of Reproductive Aging Workshop + 10: addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. Climacteric 2012; 15:105–14; Fertil Steril 2012; 97:843–51; J Clin Endocrinol Metab 2012; 97:1159–68; Menopause 2012; 19:387–95.
4. Avis NE, Crawford SL, Greendale G, et al. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. JAMA Intern Med 2015; 175:531.
5. Freeman EW, Sammel MD, Sanders RJ. Risk of long-term hot flashes after natural menopause: evidence from the Penn Ovarian Aging Study cohort. Menopause 2014; 21:924.
6. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 141: Management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol. 2014; 123(1):202–216. [PubMed: 24463691]
7. Krause & Nakajima. Hormonal and Nonhormonal treatment of vasomotor symptoms Obstet Gynecol Clin N Am 2015; 42:163-79
8. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society Vol. 24, No. 7, pp. 728-753. DOI: 10.1097/GME.0000000000000921.
9. Management of symptomatic vulvovaginal atrophy: 2013 position statement of The North American Menopause Society. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society Vol. 20, No. 9, pp. 888/902 DOI: 10.1097/gme.0b013e3182a122c2.
10. Nappi R E, Kokot-Kierepa M. Vaginal Health: Insights, Views & Attitudes (VIVA) – results from an international survey. Climacteric 2012; 15: 36 – 44. DOI: 10.3109/13697137.2011.647840.
11. Nappi R E, Palacios S. Impact of vulvovaginal atrophy on sexual health and quality of life at postmenopause. Climacteric 2014; 17:3–9. DOI: 10.3109/13697137.2013.871696.
12. Kingsberg SA, Wysocki S, Magnus L, Krychman ML. Vulvar and vaginal atrophy in postmenopausal women: findings from the REVIVE (REal Women's VIews of Treatment Options for Menopausal Vaginal ChangEs) survey. J Sex Med 2013; 10 :1790 – 9. DOI: 10.1111/jsm.12190.
13. Simon JA, Nappi RE, Kingsberg SA, Maamari R, Brown V. Clarifying Vaginal Atrophy_s Impact on Sex and Relationships (CLOSER) survey: emotional and physical impact of vaginal discomfort on North American postmenopausal women and their partners. Menopause 2014; 21:137-142.

14. Soares CN. Mood disorders in midlife women: understanding the critical window and its clinical implications. Menopause. 2014 Feb;21:198-206.
15. Parry B. Perimenopausal depression. Am J Psychiatry 2008; 165: 23-27.
16. Pérez-López FR, Pérez-Roncero G, Fernández-Iñarrea J. Resilience, depressed mood, and menopausal symptoms in postmenopausal women. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society. Vol. 21, No. 2, pp. 159/164. DOI: 10.1097/gme.0b013e31829479bb.
17. Freeman EW, Sammel MD, Lin H, Nelson DB. Associations of hormones and menopausal status with depressed mood in women with no history of depression. Arch Gen Psychiatry. 2006 Apr;63:375-82.
18. Cohen LS1, Soares CN, Vitonis AF, Otto MW, Harlow BL. Risk for new onset of depression during the menopausal transition: the Harvard study of moods and cycles Arch Gen Psychiatry. 2006; 63:385-90.
19. Bromberger JT1, Kravitz HM, Chang YF, Cyranowski JM, Brown C, Matthews KA. Major depression during and after the menopausal transition: Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). Psychol med. 2011; 41:1879-88
20. Silva I, Naftolin F. Brain health and cognitive and mood disorders in ageing women. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2013; 27:661-72
21. Zanardi R1, Rossini D, Magri L, Malaguti A, Colombo C, Smeraldi E. Response to SSRIs and role of the hormonal therapy in postmenopausal depression. Eur Neuropsychopharmacol. 2007; 17:400-5
22. Organización Mundial de la Salud (2006). Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002, Geneva.
23. Caruso S, Rapisarda A, Cianci S. Sexuality in menopausal women. Curr Opin Psychiatry 2016, 29:323–330 DOI:10.1097/YCO.0000000000000280.
24. Burri A, Hilpert P, Spector T. Longitudinal Evaluation of Sexual Function in a Cohort of Pre and Postmenopausal Women. J Sex Med 2015; 12:1427-35
25. Asociación Americana de Psiquiatría, Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría, 2013.
26. Hugh S. Taylor, MD Lubna Pal, MBBS, MS Emre Seli, MD. nl Speroffs Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility, Ninth Edition, Philadelfia, Editorial Wolters Kluwer, 2020
27. Recomendaciones para el Manejo de la Paciente en Etapa de Climaterio y Menopausia. Sociedad Peruana del Climaterio, 2020.
28. R. .J Baber, N. Panay & A. Fenton the IMS Writing Group (2016) 2016 IMS Recommendations on women's midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric, 19:2, 109-150, DOI: 10.3109/13697137.2015.1129166
29. Rojas ,J yCol. Atención del Climaterio yMenopausia en al Mujer Peruana, Diagnóstico Vol. 52(2)Abril-Junio 2013
30. Grindler NM, Santoro NF. Menopause and exercise. Menopause 2015 Sep 21.
31. Dubnov-Raz G, Pines A, Bery EM. Diet and lifestyle ni managing postmenopausal obesity. Climacteric 2007:10(Suppl 2):38-41
32. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2017 Jul;24(7):728-753. [PubMed

33. Hormone Replacement Therapy Harper-Harrison G, Shanahan M. Hormone Replacement Therapy. [Updated 2108 Feb 26]. In: StatPearls [internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing: 2018 Jan-. Available from https://www.ncbi.nim.nih.gov/books/NBK493191/
34. Vanhauwaert PS. Últimos análisis del WHI y las consecuencias de no dar terapia hormonal de la menopausia. En: Ponencia congreso de la Sociedad Argentina de Endocrinologia Ginecológica y reproductiva. XI Congreso Argentino de Endocrinología Ginecológica yReproductiva 2018. Buenos Aires 22, 23 y24 de abril de 2018 [Links]
35. Harlow SD, Gass M, Hal JE, et a.l Executive summary of the Stages of Reproductive Aging Workshop+10: addressing the unfinished agenda of staging reproductive aging. Climacteric 2012;15:105-14
36. Heinemann K, Ruebig A, Potthoff P, Schneider HP, Strelow F, Heinemann LA, al. The Menopause Rating Scale (MRS): a metodological review. Health Qual Life Outcomes. 2004:2:45. DOI: 10.1186/1477-7525-2-45.
37. Aedo S, Porcile A, Irribarra C. Calidad de vida relacionada con el climaterio en una población Chilena de mujeres saludables. Rev Chil Obstet Ginecol. 2006;71:402-9.
38. Harvey JA, Santen RJ, Petroni GR, Bovbjerg VE, Smolkin ME, Sheriff FS, Russo ,J Histologic changes in the breast with menopausal hormone therapy use: correlation with breast density, estrogen receptor, progesterone receptor, and proliferation indices, Menopause 15:67, 2008.
39. Pines A, Sturdee DW, Maciennan AH. Quality of life and the role of menopausal hormone therapy. Climateric 2012;15(3):213-6.
40. Santisteban Alba S. Atención integral a las mujeres de edad mediana. Rev Cubana Obstet Ginecol 2011;37 (2):251-70
41. Chiantera V, Sarti CD, Fornaro F. Farzati A, De Franciscis P, Sepe E, Borrelli AL, Colacurci N, Longterm effects of oral and transdermal hormone replacement therapy on plasma homocysteine levels, Menopause 10:286, 2003,
42. Keler PJ, Hotz E, Imthurn B. Atransdermal regimen for continuous combined hormone replacement therapy ni the menopause. Maturitas. 1992;15(3): 195-8.
43. Robinson D, Toozs-Hobson P, Cardozo L. The effect of hormones on the lower urinary tract. Menopause Int 2013;19:155-62
44. Rees M, Pe rez-Lo pez FR, Ceasu ,1 et al. EMAS. EMAS clinical guide: low-dose vaginal estrogens for postmenopausal vaginal atrophy. Maturitas 2012:73:171-4
45. Jatiaoui TC, Riley HEM, Curtis KM. The safety of intrauterine devices among young women: a systematic review. Contraception. 2017;95(1): 17-39
46. Sulak PJ, Caubel P, Lane R. Efficacy and safety of a constant-estrogen, pulsed- progestin regimen ni hormone replacement therapy. Int J Fertil Womens Med. 1999;44(6):286-96.
47. Straczek C, Oger E, Yon de Jonage-Canonico MB, Plu-Bureau G, Conard J, Meyer G, et al. Prothrombotic mutations, hormone therapy, and venous thromboembolism among postmenopausal women: impact of the route of estrogen administration. Circulation. 2005:112:3495500. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.565556.
48. Stute P, Becker HG, Bitzer ,J Chatsiproios D, Luzuy F, von Wolf M, Wunder D, Birkhäuser M. Ultra-low dose-new approaches ni menopausal hormone therapy. Climacteric. 2015;18(2): 182-6.

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE V°B° M.C. MOISES ENRIQUE TAMAYO ACOSTA DIRECCIÓN GENERAL

HOSPITAL NAC. HIPÓLITO UNANUE JEFATURA 137 DPTO. GINECO - OBST. ETRICIA

49. Menopause: A Comprehensive Approach. Antonio Cano, Department of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology University of Valencia, Valencia Spain Springer International Publishing AG 2017